किडनीचा आजार (CKD): रिपोर्ट समजून घ्या, काळजी कशी घ्यावी?

> किडनीचा त्रास असेल तर रिपोर्टमधले आकडे काय सांगतात, रक्तदाबाची काळजी कशी घ्यायची आणि रक्ताची कमतरता कधी तपासायची—हे सोप्या भाषेत समजून घेण्यासाठी हा लेख आहे. डॉक्टरांशी बोलताना उपयोगी पडतील असे मुद्देही यात दिले आहेत.

१. CKD म्हणजे नेमके काय?

किडनीचे काम किंवा तिच्या रचनेत झालेला बिघाड किमान ३ महिने टिकून असेल, तर त्याला दीर्घकालीन किडनीचा आजार (CKD) म्हणतात. एकदाच creatinine वाढले किंवा eGFR कमी आले म्हणून लगेच CKD ठरत नाही. ताप, उलट्या, जुलाब, शरीरात पाणी कमी होणे किंवा काही औषधांमुळेही रिपोर्ट तात्पुरता बदलू शकतो. म्हणून डॉक्टरांच्या सल्ल्याने पुन्हा तपासणी करून हा बदल कायमचा आहे का ते पाहतात.

२. रिपोर्ट पाहताना तीन गोष्टी लक्षात ठेवा

किडनीचा आजार कशामुळे झाला, किडनी किती काम करते (eGFR) आणि लघवीतून किती प्रथिने बाहेर जातात (urine ACR)—या तीन गोष्टी एकत्र पाहिल्या जातात. यालाच CGA वर्गीकरण म्हणतात. eGFR चांगला दिसत असला तरी लघवीत प्रथिने जात असतील, तर किडनीचा आजार असू शकतो.

३. eGFR आणि albuminuria categories

G1: ≥90; G2: 60–89; G3a: 45–59; G3b: 30–44; G4: 15–29; G5: <15 mL/min/1.73 m². Urine ACR: A1 <30 mg/g; A2 30–300 mg/g; A3 >300 mg/g. ACR शक्यतो spot urine (विशेषतः first-morning sample) मध्ये मोजा; abnormal result ची पुनर्तपासणी/संदर्भानुसार पुष्टी करा. KDIGO heat-map मध्ये GFR कमी आणि albuminuria जास्त होत गेल्यास जोखीम वाढते.

४. रक्तदाब योग्य पद्धतीने मोजणे महत्त्वाचे

रक्तदाब मोजण्यापूर्वी काही मिनिटे शांत बसा. हाताला योग्य आकाराचा cuff लावून, पाठ टेकवून आणि पाय जमिनीवर ठेवून मोजमाप करावे. KDIGO मधील 120 पेक्षा कमी या लक्ष्याचा अर्थ कुठेही घेतलेला कोणताही BP reading असा नाही. हे लक्ष्य ठरावीक प्रमाणित पद्धतीने घेतलेल्या मोजमापासाठी आहे. घरी BP नोंदवून डॉक्टरांना दाखवणेही उपयोगी ठरते.

५. CKD असेल तर रक्तदाब किती ठेवावा?

Dialysis सुरू नसलेल्या बहुतेक प्रौढ रुग्णांत, उपचार सहन होत असतील तर, प्रमाणित पद्धतीने मोजलेला वरचा रक्तदाब 120 mmHg पेक्षा कमी ठेवण्याचा KDIGO 2021 चा सल्ला आहे. पण उभे राहिल्यावर चक्कर येणे, BP खूप कमी होणे किंवा इतर आजार असतील तर लक्ष्य बदलावे लागू शकते. लघवीत प्रथिने जास्त असतील तर डॉक्टर ACE inhibitor किंवा ARB गटातील औषध देऊ शकतात. ही औषधे स्वतःहून सुरू किंवा बंद करू नका.

६. ACEi/ARB औषधे घेताना कोणत्या तपासण्या कराव्यात?

ही औषधे सुरू केल्यानंतर किंवा मात्रा वाढवल्यानंतर साधारण २–४ आठवड्यांनी BP, creatinine आणि potassium तपासणे गरजेचे असते. Creatinine ३०% पेक्षा जास्त वाढल्यास त्यामागचे कारण शोधावे. Potassium वाढला किंवा BP मुळे त्रास झाला तर डॉक्टर उपचारात बदल करू शकतात. रिपोर्ट बदलला म्हणून औषध अचानक बंद करण्याऐवजी डॉक्टरांशी संपर्क साधा.

७. मीठ, खाणे-पिणे आणि हालचाल

उच्च रक्तदाब आणि CKD असल्यास दिवसाचे मीठ साधारण ५ ग्रॅमपेक्षा कमी ठेवण्याचा सल्ला दिला जातो. मात्र काही रुग्णांत मीठ कमी करणे योग्य नसेल—म्हणून स्वतःहून कडक आहार सुरू करू नका. Potassium असलेले low-sodium salt काही किडनी रुग्णांसाठी धोकादायक ठरू शकते. तब्येत आणि ताकद पाहून नियमित चालणे किंवा हलका व्यायाम करा. शक्य असल्यास आठवड्याला एकूण १५० मिनिटांचे मध्यम स्वरूपाचे चालणे/व्यायाम हे उद्दिष्ट ठेवता येते.

८. किडनीच्या आजारात रक्ताची कमतरता (ॲनिमिया)

CKD असलेल्या व्यक्तींमध्ये हिमोग्लोबिन कमी होऊ शकते. थकवा, अशक्तपणा किंवा दम लागणे अशी लक्षणे असतील तर डॉक्टरांना सांगा. तपासण्यांमध्ये CBC, reticulocyte count, ferritin आणि TSAT यांचा समावेश होतो. KDIGO 2026 नुसार साधारण तपासणीचे अंतर: G3 मध्ये वर्षातून एकदा, G4 मध्ये वर्षातून दोनदा आणि G5 किंवा dialysis मध्ये दर तीन महिन्यांनी. लक्षणे किंवा रक्तस्राव असल्यास आधी तपासणी लागू शकते.

९. Iron deficiency आणि iron therapy — thresholds

KDIGO 2026: Hemodialysis (CKD G5HD) मध्ये anemia असल्यास ferritin ≤500 ng/mL आणि TSAT ≤30% असल्यास iron therapy सुरू करण्याचा विचार (2D); सुरुवातीला IV iron ला oral पेक्षा प्राधान्य सुचविले आहे. Dialysis नसलेल्या CKD किंवा peritoneal dialysis मध्ये iron विचारात घ्या: ferritin <100 आणि TSAT <40%, किंवा ferritin 100 ते <300 आणि TSAT <25%. Hemodialysis नसताना oral किंवा IV मार्ग रुग्णाची पसंती, anemia/iron deficiency ची तीव्रता, सहनशीलता, उपलब्धता व खर्च यानुसार ठरतो. Routine iron थांबवण्याचा विचार ferritin >700 किंवा TSAT ≥40% असल्यास. हे treatment thresholds आहेत; isolated lab result वर स्वतःहून iron देऊ नका.

१०. Iron monitoring, ESA आणि transfusion निर्णय

Iron घेत असताना Hb, ferritin, TSAT: non-dialysis/PD मध्ये साधारण दर ३ महिन्यांनी; HD मध्ये दर १–३ महिन्यांनी. Optimal oral iron नंतर १–३ महिन्यांत परिणाम अपुरा किंवा सहन न झाल्यास IV iron विचारात घ्या; systemic infection मध्ये iron तात्पुरते थांबवण्याचा विचार. ESA/HIF-PHI पूर्वी iron deficiency, रक्तस्राव, infection/inflammation, B12/folate deficiency, thyroid/PTH आणि इतर reversible causes तपासा. Correctable causes सुधारल्यानंतर ESA हे HIF-PHI पेक्षा first-line सुचविले आहे (2D). Adult CKD रुग्णांत ESA चालू असताना Hb target <11.5 g/dL ठेवा. Dialysis वर ESA सुरू करण्याचा विचार Hb at or below 9–10 g/dL येथे; non-dialysis मध्ये लक्षणे व transfusion/ESA जोखीम वैयक्तिकरीत्या तोला. RBC transfusion चा निर्णय Hb आकड्यावरच नव्हे तर लक्षणे, urgency आणि clinical context वर घ्या.

११. क्लिनिकल safety points

NSAIDs, contrast, antibiotics व इतर औषधांचा renal function नुसार विचार करा; औषधांचा dose eGFR नुसार समायोजित करावा. Potassium, volume status, BP, creatinine/eGFR आणि albuminuria यांचे trend पाहा. अचानक oliguria, वेगाने वाढणारी सूज/दम, chest pain, syncope, गंभीर hyperkalemia संशय किंवा uremic complication असल्यास तातडीची clinical assessment आवश्यक. हा लेख dialysis prescription, transplant किंवा pediatric CKD साठी स्वतंत्र protocol नाही.

जीवाला धोका असलेल्या स्थितीत भारतात ११२ वर संपर्क करा. इतर देशांत स्थानिक आपत्कालीन क्रमांक वापरा.

१२. वापरासाठी झटपट checklist

☐ CKD chronicity ≥3 months पुष्टी? ☐ Cause + G category + A category नोंदवली? ☐ eGFR आणि urine ACR trend उपलब्ध? ☐ BP standardized पद्धतीने मोजला? ☐ ACEi/ARB indication आणि potassium/creatinine monitoring ठरवले? ☐ CBC/reticulocyte/ferritin/TSAT schedule ठरवले? ☐ औषधांचे renal dose review? ☐ nephrology referral/urgent escalation ची गरज तपासली?

डायलिसिस आणि किडनीची रोजची काळजी — लघवी दिसते; सगळी स्वच्छता दिसत नाही

डायलिसिस सुरू झाल्यावरही काही जणांची लघवी चालू असते. त्यामुळे “किडनी काम करतेय, मग हे उपचार कशाला?” असे वाटू शकते. पण पाणी बाहेर जाणे आणि रक्तातला टाकाऊ पदार्थ व पोटॅशियम योग्य प्रमाणात ठेवणे ही एकच गोष्ट नाही. उरलेले किडनीचे काम किती पुरतेय, हे **फक्त लघवी पाहून ठरत नाही**.

डायलिसिस आणि किडनीची रोजची काळजी — उपचारांचे वेळापत्रक कसे ठरते?

डॉक्टर रक्ताच्या तपासण्या, सूज, श्वासाचा त्रास, वजनातील बदल, उरलेले किडनीचे कार्य आणि डायलिसिसमधून होणारी पुरेशी शुद्धी पाहतात. एकाला चालणारे वेळापत्रक दुसऱ्याला सुरक्षित असेलच असे नाही. प्रवास, खर्च किंवा कामाच्या अडचणी असतील तर त्या नक्की सांगा; त्यासाठी सत्र स्वतःहून चुकवण्याऐवजी टीमबरोबर उपाय शोधता येतील.

डायलिसिस आणि किडनीची रोजची काळजी — पाणी आणि खाणे: दुसऱ्याची यादी आपल्या ताटात नको

सर्वांसाठी एक लिटर पाणी किंवा अतिशय कमी प्रथिने असा नियम नाही. डायलिसिसचा प्रकार, लघवी, तपासण्या आणि पोषण यानुसार योजना बदलते. डायलिसिस चालू असताना प्रथिनांची गरज वेगळी असू शकते. शेजाऱ्याचे पथ्य पाळून स्वतःचे खाणे कमी केल्यास ते आपल्यासाठी योग्य असेलच असे नाही.

डायलिसिस आणि किडनीची रोजची काळजी — घरी नोंद काय ठेवायची?

पुढच्या भेटीसाठी वजन, सूज, दम लागण्याची वेळ, भूक, लघवीत जाणवलेला बदल आणि घेत असलेली औषधे लिहून ठेवा. पाण्याची मर्यादा सांगितली असेल तर चहा, दूध, सूप यांची त्यात मोजणी कशी करायची हेही विचारा. आपला ठरलेला कार्यक्रम पाळा; बदल हवा असेल तर आधी उपचार करणाऱ्या टीमशी बोला.

> ### डायलिसिस आणि किडनीची रोजची काळजी — केव्हा थांबायचे नाही?
>
> **तीव्र दम**, छातीत दुखणे, बेशुद्धी किंवा अचानक खूप अस्वस्थ वाटत असेल तर तातडीची वैद्यकीय मदत घ्या. डायलिसिसचे सत्र चुकले असेल, सूज वाढत असेल किंवा लघवी नेहमीपेक्षा खूप कमी झाली असेल तर त्याच दिवशी टीमला कळवा. पुढच्या नियोजित भेटीपर्यंत शांतपणे वाट पाहणे योग्य नाही.
>
> जीवाला धोका असलेल्या स्थितीत भारतात ११२ वर संपर्क करा. इतर देशांत स्थानिक आपत्कालीन क्रमांक वापरा.

डायलिसिस आणि किडनीची रोजची काळजी — पोटॅशियम शत्रू नाही

पोटॅशियम हे स्नायू, मज्जातंतू आणि हृदयाच्या कामासाठी लागणारे खनिज आहे. निरोगी किडनी जास्तीचे पोटॅशियम मुख्यतः लघवीतून बाहेर टाकते. किडनीचे काम कमी झाल्यावर ते पुरेसे बाहेर काढणे कठीण होऊ शकते. “अजिबात बाहेर पडतच नाही” असे सर्व रुग्णांबद्दल म्हणणे अचूक नाही.

डायलिसिस आणि किडनीची रोजची काळजी — किडनीचा आजार म्हणजे पोटॅशियम नेहमी जास्त?

नाही. पातळी जास्त, सामान्य किंवा कमीही असू शकते. रक्ताची तपासणी, किडनीचे कार्य, डायलिसिस, औषधे आणि आहार पाहून सल्ला ठरतो. काही औषधे किंवा पोटॅशियम असलेले पूरक पदार्थ आणि मीठाचे पर्यायही महत्त्वाचे असतात. **औषधे स्वतः बंद करू नका**; सगळी यादी डॉक्टरांना दाखवा.

डायलिसिस आणि किडनीची रोजची काळजी — मग शहाळ्याच्या पाण्याचे काय?

शहाळ्याच्या पाण्यात पोटॅशियम असते. रक्तात पोटॅशियम वाढले असेल, ते कमी ठेवण्याचा सल्ला दिला असेल किंवा पाण्याची मर्यादा असेल तर डॉक्टरांच्या परवानगीशिवाय ते पिऊ नका. पण प्रत्येक निरोगी व्यक्तीला किंवा किडनीच्या प्रत्येक रुग्णाला कायमची बंदी हा योग्य एकच नियम नाही. प्रमाण, तपासणी आणि वैयक्तिक योजना महत्त्वाची; शहाळ्याचे पाणी किडनी स्वच्छ करणारा उपचारही नाही.

डायलिसिस आणि किडनीची रोजची काळजी — लघवी होतेय म्हणजे पोटॅशियम बरोबर असेल?

फक्त लघवीचे प्रमाण पाहून रक्तातले पोटॅशियम समजत नाही. तसेच बरे वाटतेय म्हणून वाढलेले पोटॅशियम नाकारता येत नाही. डॉक्टरांनी पुन्हा तपासणी सांगितली असेल तर ती करा. उकडलेली भाजी किंवा एखादा घरगुती पदार्थ खाऊन धोकादायक पातळी लगेच कमी करता येत नाही.

डायलिसिस आणि किडनीची रोजची काळजी — भाजीचे लीचिंग म्हणजे काय—आणि काय नाही?

काही भाज्या ठराविक पद्धतीने भिजवून किंवा भरपूर पाण्यात शिजवून ते पाणी टाकल्यास त्यातील काही पोटॅशियम कमी होऊ शकते. ते **सगळे निघत नाही**. त्यामुळे भाजी अमर्याद खाणे सुरक्षित ठरत नाही. कोणती भाजी, किती प्रमाण आणि नेमकी पद्धत हे किडनीच्या आहारतज्ज्ञाकडून घ्या; पोटॅशियम सामान्य असताना सर्व भाज्या उकडून पाणी टाकण्याचा सरसकट नियम करू नका.

डायलिसिस आणि किडनीची रोजची काळजी — डॉक्टरांना हे तीन प्रश्न विचारा

“माझे आताचे पोटॅशियम किती आहे?”, “माझ्यासाठी कोणत्या पदार्थाचे किती प्रमाण चालेल?” आणि “पुढची तपासणी कधी?”—हे लिहून विचारा. सगळेच फळ-भाजी बंद करून खाण्याची भीती वाढवण्याऐवजी घरच्या जेवणात बसणारी स्पष्ट योजना मागा.

> ### डायलिसिस आणि किडनीची रोजची काळजी — कधी घरगुती उपाय नको?
>
> तपासणी करणाऱ्या केंद्राने किंवा डॉक्टरांनी पोटॅशियम धोकादायक असल्याचे सांगितले तर **लक्षणे नसली तरी** दिलेला तातडीचा सल्ला पाळा. धडधड, तीव्र अशक्तपणा, बेशुद्धी किंवा छातीत त्रास असेल तर तातडीची वैद्यकीय मदत घ्या. शहाळ्याचे पाणी बंद करणे किंवा भाजी उकडणे हे अशा स्थितीचे आपत्कालीन उपचार नाहीत.
>
> जीवाला धोका असलेल्या स्थितीत भारतात ११२ वर संपर्क करा. इतर देशांत स्थानिक आपत्कालीन क्रमांक वापरा.

मनातले प्रश्न

रिपोर्टमध्ये eGFR 58 एकदाच आले तर CKD आहे का?

लगेच असे म्हणता येत नाही. हा बदल तीन महिन्यांपेक्षा जास्त टिकतो का, urine ACR काय आहे आणि इतर काही पुरावे आहेत का, हे डॉक्टर तपासतात.

प्रत्येक CKD रुग्णाचा BP 120 पेक्षा कमीच हवा का?

नाही. हे लक्ष्य dialysis नसलेल्या प्रौढांसाठी आणि ठरावीक पद्धतीने मोजलेल्या BP साठी आहे. चक्कर, अशक्तपणा किंवा इतर आजार असल्यास डॉक्टर वेगळे लक्ष्य ठरवू शकतात.

ACEi/ARB सुरू केल्यावर creatinine वाढले तर औषध बंद करायचे का?

स्वतःहून बंद करू नका. औषध सुरू केल्यानंतर किंवा मात्रा वाढवल्यानंतर २–४ आठवड्यांनी तपासणी करतात. Creatinine ३०% पेक्षा जास्त वाढल्यास डॉक्टर कारण शोधून पुढचा निर्णय घेतात.

KDIGO 2026 ची मार्गदर्शक तत्त्वे संपूर्ण CKD उपचारांबद्दल आहेत का?

नाही. ती मुख्यतः CKD मुळे होणाऱ्या रक्ताच्या कमतरतेची तपासणी आणि उपचार याबद्दल आहेत.

“लघवी चालू आहे” म्हणजे डायलिसिस कमी करता येईल?

नाही, एवढ्यावर निर्णय होत नाही. किती सत्रे आवश्यक आहेत हे तपासण्या आणि एकूण स्थिती पाहून किडनीचे तज्ज्ञ ठरवतात.

डायलिसिस म्हणजे किडनी पूर्ण बरी झाली?

डायलिसिस रक्तातले काही टाकाऊ पदार्थ आणि जास्तीचे पाणी काढण्याचे काम करतो. तो किडनी निकामी होण्याचा कायमचा इलाज नाही.

शहाळ्याचे पाणी पूर्ण बंदच?

सर्वांसाठी नाही. वाढलेले पोटॅशियम किंवा वैयक्तिक मर्यादा असल्यास परवानगी मिळेपर्यंत टाळा; पुढचा निर्णय तपासणीनुसार घ्या.

भाजी उकडली की सर्व पोटॅशियम निघते?

नाही. काही कमी होऊ शकते; प्रमाण आणि संपूर्ण आहार अजूनही महत्त्वाचे असतात.

लक्षणे नाहीत, मग पोटॅशियम कसे वाढेल?

रक्तातली पातळी फक्त आपण कसे वाटते यावरून कळत नाही. म्हणून सांगितलेली रक्ताची तपासणी आवश्यक आहे.

लक्षात ठेवण्याची गोष्ट

CKD चे मूल्यांकन CGA ने करा; BP चे लक्ष्य फक्त standardized measurement वर लागू करा; RASi/iron/ESA उपचारांमध्ये potassium, creatinine, Hb आणि iron indices यांचे नियोजित monitoring अत्यावश्यक आहे.

आधार आणि मूळ संदर्भ

KDIGO 2024 — CKD Evaluation and Management guideline
https://kdigo.org/guidelines/ckd-evaluation-and-management/

KDIGO 2021 — Blood Pressure in CKD guideline
https://kdigo.org/guidelines/blood-pressure-in-ckd/

KDIGO 2026 — Anemia in CKD guideline
https://kdigo.org/guidelines/anemia-in-ckd/

NIDDK — hemodialysis
https://www.niddk.nih.gov/health-information/kidney-disease/kidney-failure/hemodialysis

NIDDK — healthy eating with chronic kidney disease
https://www.niddk.nih.gov/health-information/kidney-disease/chronic-kidney-disease-ckd/healthy-eating-adults-chronic-kidney-disease

NIDDK — eating and nutrition on hemodialysis
https://www.niddk.nih.gov/health-information/kidney-disease/kidney-failure/hemodialysis/eating-nutrition

American Heart Association — changes to report
https://www.heart.org/en/health-topics/heart-failure/living-with-heart-failure-and-managing-advanced-hf/physical-changes-to-report-for-heart-failure

NIH Office of Dietary Supplements — potassium
https://ods.od.nih.gov/factsheets/potassium-Consumer/

National Kidney Foundation — potassium and food preparation
https://www.kidney.org/kidney-topics/potassium-your-ckd-diet

National Kidney Foundation of Hawaii — coconut water
https://kidneyhawaii.org/blog/is-coconut-water-good-for-my-kidneys/

National Kidney Foundation — high potassium and urgent treatment
https://www.kidney.org/kidney-topics/hyperkalemia-high-potassium

Government of India — Emergency Response Support System 112
https://112.gov.in/about

ही माहिती समजून घेण्यासाठी आहे. वैयक्तिक उपचारासाठी आपल्या डॉक्टरांची योजना पाळा. औषधे स्वतः बदलू नका. संदर्भ तपासले: २४ ऑक्टोबर २०२६.

Website: https://home-visiting-icu-doctor.vercel.app/#wikiSection
Article: ckd-kdigo | mr